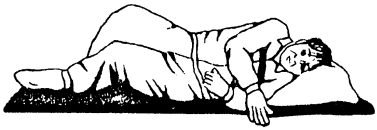
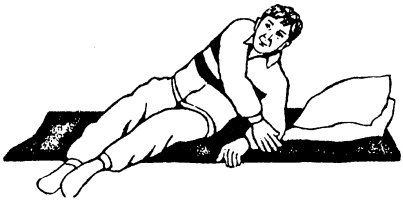
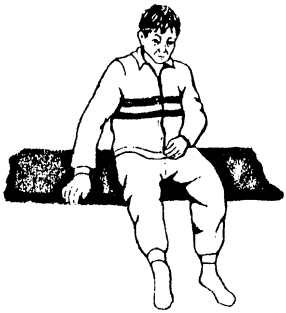
Реабилитация и уход после инсульта

понятным языком — о самом главном

для пациента и семьи: в отделении и дома







Двигаться **Заботиться** **Беречь себя**

Памятка для пациента и родственников

в отделении и дома

Коротко о главном 10 правил

1. **Начинайте реабилитацию рано и занимайтесь каждый день**
— восстановление идёт через повторение, активнее всего в первые 3–6 месяцев.

2. **Меняйте положение каждые 2 часа**
лучше всего — на здоровом боку, больная рука и нога на подушках.

3. **Никогда не тяните за больную руку**
и не поднимайте за подмышки — это вывих и боль в плече.

4. **Помогайте, а не делайте вместо**
пусть пациент делает всё, что может, сам.

5. **Включайте больную руку и ногу во все дела**
— вставать, ходить, есть, одеваться.

6. **Берегитесь падений**
— безопасный дом, удобная обувь, опора под рукой.

7. **Одевайте с больной стороны**
раздевайте — со здоровой.

8. **Воду проверяйте локтем, зубы чистите 2 раза в день**
— это защита от ожогов и пневмонии.

9. **Давление ниже 130/80, лекарства — каждый день**
без перерывов, не отменяйте сами.

10. **Следите за настроением и берегите себя**
— уставший помощник не поможет долго.

Что такое инсульт

Инсульт — **острое нарушение кровообращения мозга**. Клетки мозга без кислорода гибнут, и нарушается то, чем управлял этот участок.

Ишемический — около 80 %

Сосуд закупорен тромбом: чаще всего на **атеросклеротической бляшке** или тромб пришёл из сердца.

Геморрагический — около 20 %

Сосуд разорвался, кровь излилась в мозг. Главная причина — **высокое давление**.

Что может нарушиться

- движения и равновесие, чувствительность;
- речь и глотание, зрение;
- память, внимание, настроение;
- контроль мочеиспускания и стула; быстрая утомляемость.

Восстановление возможно

Здоровые участки мозга учатся брать на себя работу погибших. Нужны **ранняя, регулярная реабилитация** и терпение: восстановление занимает месяцы и годы.

Признаки инсульта — «Лицо, Рука, Речь, Время»:

- **лицо** — перекос, улыбка несимметрична;
- **рука** или нога — внезапная слабость, онемение;
- **речь** — невнятная, непонятная.

Время — сразу звоните **103** или **112** и запомните время начала.

Как проходит реабилитация

Реабилитацию начинают **в первые 48 часов** в отделении и продолжают дома. Активнее всего восстановление идёт в первые **3–6 месяцев**, но улучшение возможно и через год.

1 **Этап 1 — отделение для больных с ОНМК**
Команда занимается каждый день: положение, вставание, ходьба, речь, глотание, самообслуживание.

2 **Этап 2 — отделение медицинской реабилитации**
Интенсивные занятия в стационаре, если нарушения выраженные.

3 **Этап 3 — амбулаторно**
Поликлиника, дневной стационар, реабилитация на дому и дистанционно.

Команда и план

Врач физической и реабилитационной медицины, специалисты по физической реабилитации и эргореабилитации, логопед, медицинский психолог, медицинская сестра — вместе с лечащим врачом. Цели записывают в **индивидуальный план медицинской реабилитации**. Пациент и семья — участники команды.

Как оценивают успехи

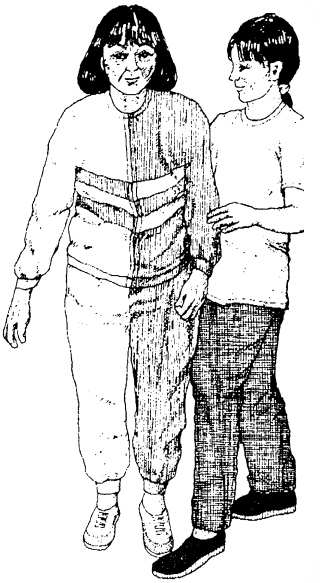
По шкалам: ходьба (Ривермид), тонус мышц (Ашворт), самообслуживание (Бартел), память (МоСА), настроение (HADS), маршрут реабилитации (ШРМ). Спросите врача о результатах.

Как помогать правильно

На рисунках **больная сторона заштрихована**. Если у вашего близкого поражена другая сторона — делайте всё так же, только зеркально.

Помощнику

- договоритесь заранее, что и как будете делать, — командуйте: «раз, два — встаём»;
- помогайте движениям пациента, а не переносите его своими силами;
- уберите всё лишнее, нужное положите ближе;
- стойте как можно ближе к пациенту, обычно — **с больной стороны**.



Берегите свою спину

- устойчивая обувь без каблуков, свободная одежда;
- стопы на ширине плеч, носками в сторону движения;
- сгибайте ноги, спина прямая, поворачивайтесь всем телом, а не скручивайтесь;
- устали — отдохните; тяжело — попросите второго помощника.

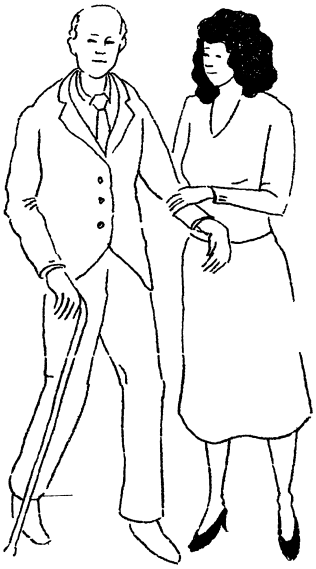
Сначала научитесь у специалистов отделения: медицинская сестра и инструктор покажут приёмы на вашем близком.

Поддержка каждый день

Восстановление занимает месяцы, а иногда и годы: здоровые участки мозга учатся брать на себя работу повреждённых. Ваша поддержка — важная часть лечения.

Как помочь

- **одинаковый распорядок дня** — даёт спокойствие и пациенту, и вам;
- включите в распорядок **короткие тренировки** утраченных навыков — несколько раз в день;
- нужно терпение: улучшение идёт медленно;
- **хвалите** даже за маленькие достижения;
- помогайте вовремя и в меру: **вместе, а не вместо** — так возвращается самостоятельность.



Наблюдайте и записывайте

Что изменилось в лучшую и в худшую сторону: движения, речь, глотание, настроение, сон, мочеиспускание и стул. Рассказывайте об этом врачу и медсестре.

Кто поможет

Реабилитационная команда: врач физической и реабилитационной медицины, специалисты по физической реабилитации и эргореабилитации (бытовые навыки), логопед, медицинский психолог, медицинская сестра. **Не стесняйтесь переспрашивать.**

Берегите больное плечо

Мышцы больной руки слабые и плохо держат плечевой сустав. Если тянуть за руку, легко вызвать **вывих и сильную боль в плече**.







✓ Правильно

- поднимайте руку, поддерживая её **под плечо и за локоть** (1-й рисунок);
- сам пациент держит больную руку здоровой ладонью снизу под локоть;
- сидя — больная рука на подушке, на столе или подлокотнике, не свисает.

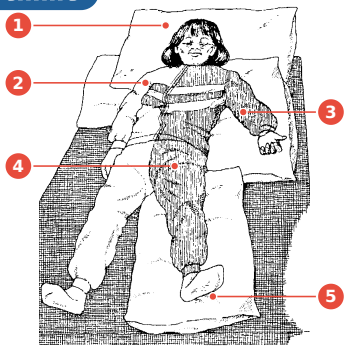
× Нельзя

- тянуть и поднимать за кисть (2-й рисунок);
- поднимать за подмышку с больной стороны (3-й рисунок);
- при повороте и пересаживании тянуть за руку.

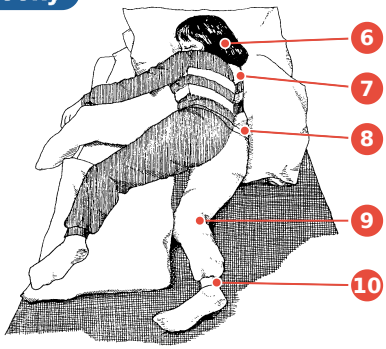
Кожа и пролежни

Пролежень появляется за несколько часов, а лечится неделями. **Меняйте положение каждые 2 часа.**

На спине



На боку



Где появляются пролежни

1. затылок
2. лопатки
3. локти
4. крестец, ягодицы
5. пятки
6. ухо
7. плечо
8. бедро сбоку
9. колени
10. лодыжки

Каждый день

- осматривайте кожу утром и вечером: покраснение, которое не проходит за 30 минут, — начало пролежня;
- кожа чистая и сухая, простыня без складок; не тяните по простыне;
- грелки на больную сторону — нельзя: она плохо чувствует ожог.

Лежать на здоровом боку

лучшее положение

✓ Правильно



1. Подушки под спину — чтобы не скатиться назад.
2. Больная нога согнута и лежит **впереди на подушке**, здоровая — почти прямая, сзади.
3. Больная рука выпрямлена вперёд и лежит на подушке, пальцы ровно. Под голову — не больше одной-двух подушек.

× Неправильно



Лежать на больном боку

✓ Правильно



× Неправильно

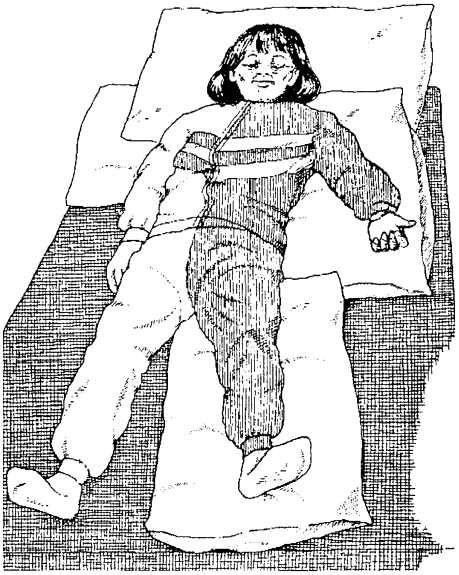


1. Подушка под спину.
2. Больное плечо и руку **вынести вперёд**, рука выпрямлена, ладонью вверх. **Нельзя лежать на больной руке!**
3. Больная нога почти прямая, колено слегка согнуто.
4. Здоровая нога согнута и лежит впереди на подушке.

Лежать на больном боку полезно — так рука и нога лучше «чувствуют». Если больно в плече — выберите другое положение.

Лежать на спине

✓ Правильно



1. Две подушки «домиком» под плечи и голову: голова посередине, лицо вверх.
2. Больное плечо и рука на подушке, рука развёрнута ладонью вверх.
3. Подушка под больное бедро — чтобы нога не разворачивалась наружу, колено слегка согнуто.

На спине мышцы сильнее «сковываются» — не оставляйте пациента в этом положении надолго. Головной конец кровати можно приподнять, если так назначил врач.

Сидеть в кровати

✓ Правильно



× Неправильно

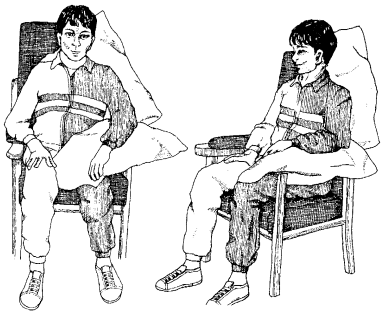


1. Сидеть **прямо**, спина у изголовья, подушка под спину.
2. Вес на обеих ягодицах, голова прямо.
3. Больная рука выпрямлена на подушке перед собой.
4. Подушка снаружи больного бедра — нога не разворачивается.

Есть, пить, читать лучше сидя в кресле. Не сидите долго полулёжа — давит на крестец и пятки, легко поперхнуться.

Сидеть в кресле

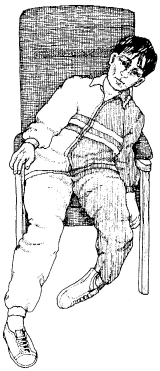
✓ Правильно



1. Кресло с подлокотниками и высокой прямой спинкой.
2. Спина прижата к спинке, вес на обеих ягодицах.
3. Тазобедренные, коленные и голеностопные суставы — **под прямым углом**, стопы стоят на полу.
4. Больная рука на подушке на подлокотнике или на столе; ещё одна подушка — под больное плечо сбоку.

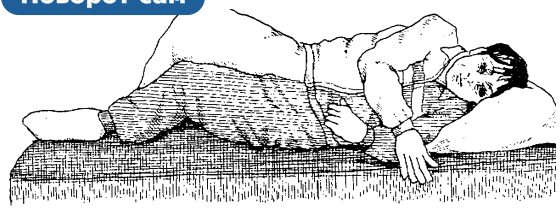
Так нельзя

Стопа больной ноги выдвинута вперёд, тело заваливается на больную сторону, рука свисает — пациент сползает с кресла.

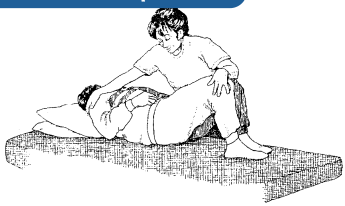


Повернуться и подвинуться в кровати

Поворот сам



Поворот с помощником



К изголовью



Повернуться на больной бок

- согнуть колени, больную руку отвести от тела или положить на грудь;
- повернуть голову, оттолкнуться здоровой ногой — повернуть колени и плечи;
- помощник — с больной стороны, держит за **здоровое плечо, колено или таз**.

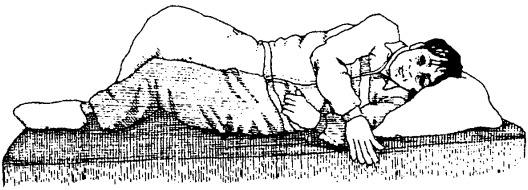
Подвинуться к изголовью

- сесть, ноги согнуты, больная рука на колене; опираясь на здоровую руку и пятку, понемногу двигаться назад;
- помощник с больной стороны: рука — вокруг таза, другая — под больное бедро; двигаться вместе, по команде.

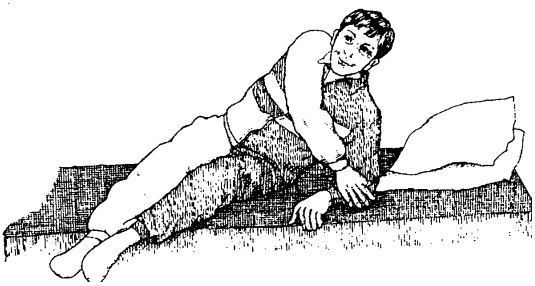
Встать с кровати самостоятельно

через больной бок

Этап 1



Этап 2



Этап 3



1. Согнуть колени и повернуться на больной бок.
2. Спустить ноги с кровати, здоровой ногой помогая больной.
3. Здоровую ладонь поставить на матрас перед собой, оттолкнуться и сесть.

Встать с кровати с помощником

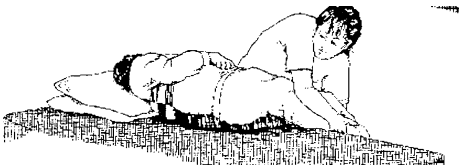
Этап 1



Этап 2



Этап 3



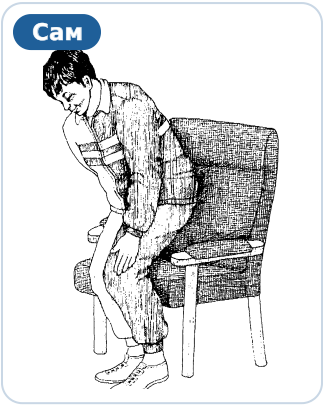
Этап 4



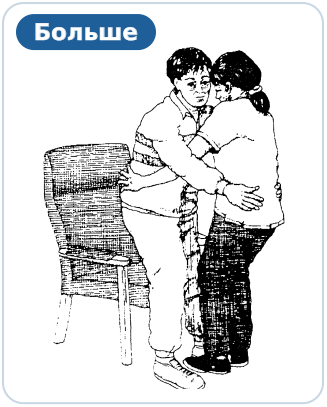
1. Помощник с больной стороны, руки — на здоровое колено и плечо: помогает повернуться на бок.
2. Спустить ноги с кровати.
3. Пациент опирается здоровой ладонью о матрас и садится.
4. Если трудно — помощник поддерживает одной рукой под больную лопатку, другой — за здоровое бедро.

Нельзя держать пациента за шею и тянуть за больную руку.

Встать со стула







1. Сдвинуться на край сиденья, стопы на ширине плеч, чуть под себя.
2. **Наклониться вперёд** — плечи над коленями, вес на обе стопы.
3. Оттолкнуться и выпрямиться, держать равновесие.

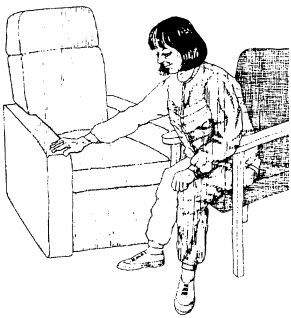
Помощник

- немного помочь: стоит с больной стороны, одна рука — на спине, другая — на больном колене, не даёт ему подогнуться;
- больше помочь: стоит лицом к пациенту, колени упирает в больное колено, держит за талию или таз; пациент кладёт здоровую руку на плечо помощника, **не за шею**.

Не опирайтесь на неустойчивое: раковину, ручку двери, лёгкий стул.

Пересесть со стула на стул

Сам



Помощь 1



Помощь 2



1. Поставить второе кресло рядом под прямым углом, лучше со здоровой стороны.
2. Сдвинуться на край, наклониться вперёд, здоровой рукой взяться за дальний подлокотник.
3. Привстать, повернуться спиной к креслу и медленно сесть поглубже.

С помощником

Помощник стоит лицом, держит за талию, своим коленом и стопой поддерживает больное колено и стопу и помогает сделать маленькие шаги. Садясь, приседает вместе с пациентом.

Пересесть, если не может встать сам

Этап 1



Этап 2



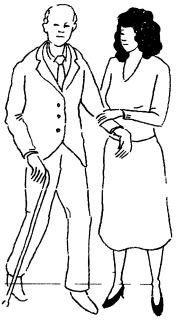
1. Стопы пациента на полу, на ширине плеч; сдвинуться на край сиденья.
2. Помощник колени и стопы прижимает к больному колену и стопе.
3. Пациент кладёт здоровую руку на плечо помощника (**не за шею**), сильно наклоняется вперёд.
4. Помощник держит за таз или спину, слегка отклоняется назад — пациент встаёт, поворачивается и садится.

Если пересаживание тяжело для помощника — спросите специалиста о приспособлениях: скользящая доска, поворотный диск, подъёмник.

Ходьба и нога

Каждый день

- вставать, стоять у опоры;
- ходить по комнате, потом по коридору и на улице;
- учиться поворачиваться, ходить по лестнице;
- нагрузку увеличивать постепенно — как скажет специалист.



Опора

Поручень → ходунки или трость с 4 опорами → трость → без опоры. Трость — **в здоровой руке**, высота — до запястья. Если стопа «свисает», специалист подберёт ортез.

Упражнения для ноги — 1–2 раза в день

1. Лёжа: стопы на себя — от себя, 8–12 раз.
2. Лёжа: скользить пяткой к ягодице и выпрямлять ногу, 8–10 раз.
3. «Мостик»: поднять таз на 2–3 секунды, 6–8 раз.
4. Сидя: выпрямить ногу в колене, 8–10 раз.
5. Встать — сесть со стула, 5–10 раз.
6. Стоя у опоры: переносить вес с ноги на ногу, 10 раз.

Полный комплекс — в памятке «Лечебная гимнастика».

Дом без падений

Уберите коврики и провода, включайте ночник, носите обувь с задником. Закружилась голова — сразу сядьте.

Рука и кисть

Слабость руки после инсульта бывает очень часто. Рука восстанавливается, только если ею **пользоваться**.

Главные правила

- многократно повторяйте движения, постепенно усложняя;
- включайте больную руку во все дела: держать чашку, застёгивать пуговицы, открывать крышку, писать;
- занимайтесь сидя за столом, рука лежит на столе.

Упражнения — 2–3 раза в день

1. Здоровой рукой разогнуть пальцы и кисть больной руки, удержать 15–30 секунд, 3–5 раз.
2. Кисти в «замке»: здоровая рука ведёт вверх — вниз, 10 раз.
3. Сжимать мягкий мяч больной рукой, 10–15 раз.
4. Перекладывать пуговицы, фасоль из миски в миску — 20–30 штук.
5. Ставить кисть на стол по очереди: кулаком, ребром, ладонью — 5–10 серий.

Полный комплекс — в памятке «Восстанавливаем руку после инсульта».

Что назначит специалист

- рукавицу на здоровую руку на несколько часов — чтобы работала больная;
- зеркальную и мысленную тренировку;
- электростимуляцию мышц, тренажёры.

Спастичность

Спастичность — **повышенный тонус мышц**: рука или нога «тянет», её трудно согнуть или разогнуть. Бывает у 25–40 % пациентов, появляется через недели или месяцы после инсульта.

Рука

- плечо прижато к телу;
- локоть согнут;
- кисть сжата в кулак;
- большой палец прижат к ладони.

Нога

- колено разогнуто, «не гнётся»;
- бёдра сведены;
- стопа повёрнута внутрь;
- большой палец поднят вверх.

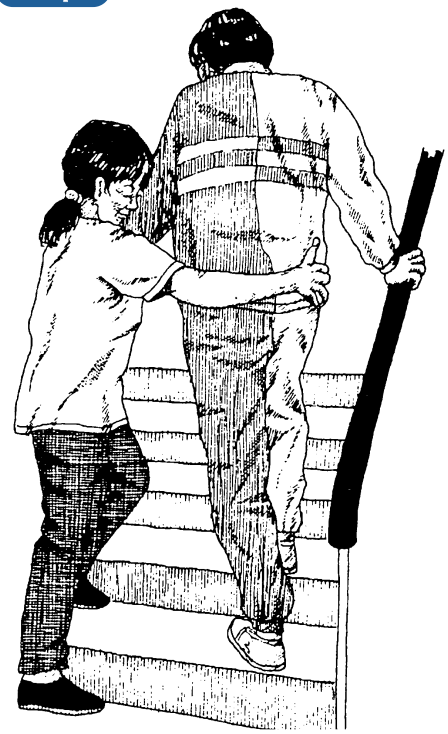
Что помогает

- **правильное положение** руки и ноги в постели и сидя — как на рисунках этой памятки;
- **растяжка и упражнения** каждый день;
- **ботулинотерапия** — уколы в мышцы по назначению врача;
- лекарства — только по назначению врача.

Чем раньше заметить, тем легче лечить. При подозрении на спастичность сразу скажите врачу.

Лестница вверх — здоровой, вниз — больной

Вверх



Вниз

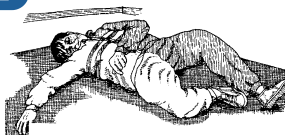


- **вверх**: сначала здоровая нога, потом больная; помощник сзади с больной стороны, рука — на бедре;
- **вниз**: сначала больная нога, потом здоровая; помощник впереди, ниже на ступеньку;
- держаться за перила; трость — в здоровой руке; на лестнице светло, без ковриков.

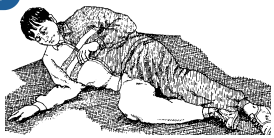
Если пациент упал

Не торопитесь поднимать! Сделайте несколько глубоких вдохов, проверьте, нет ли травмы, особенно с больной стороны.

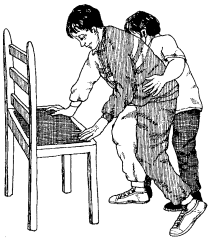
Шаг 1



Шаг 2



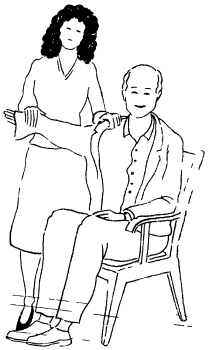
Шаг 3

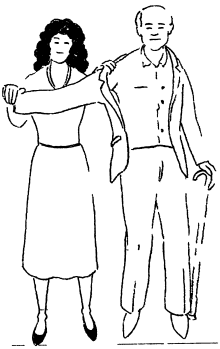


1. Повернуться на здоровый бок: больную руку положить на живот, колени согнуть.
2. Опереться на здоровый локоть и сесть боком.
3. Встать на колени перед устойчивым стулом, опереться предплечьями, поставить здоровую ногу и встать; повернуться и сесть.

Сильная боль, не может опереться на ногу, ударился головой, после нескольких попыток не встаёт — **не поднимайте, вызывайте скорую: 103 или 112**.

Одевание больная сторона — первой





Одевать — с больной стороны, раздевать — со здоровой

1. Одеваться **сидя** на устойчивом стуле с подлокотниками.
2. Одежду сложить по порядку: сверху — то, что надеть первым.
3. С больной рукой — бережно, не тянуть за неё.

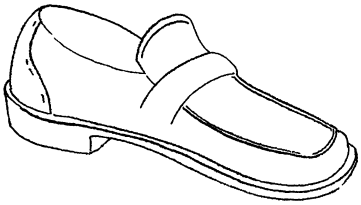
Рубашка, пиджак

1. рукав — на **больную руку**, до плеча;
2. ворот — за спину на здоровое плечо;
3. здоровую руку — во второй рукав, застегнуть.

Брюки

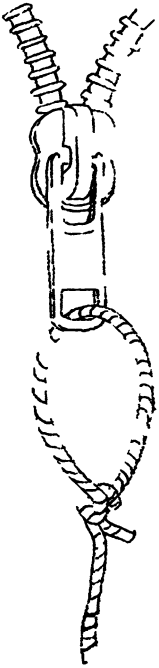
1. сидя: штанину — на **больную ногу**, потом на здоровую;
2. подтянуть до колен, обуться;
3. встать с опорой, подтянуть брюки — помощник страхует.

Удобная одежда и обувь



Одежда

- свободная: широкие рукава и пройма, брюки не узкие;
- застёжка спереди — лучше не надевать через голову;
- липучки вместо пуговиц, резинка вместо ремня и подтяжек;
- носки без тугой резинки.



Обувь

- без шнурков или на липучках;
- с задником, на низком нескользящем каблуке;
- рожок для обуви с длинной ручкой.

Простые помощники

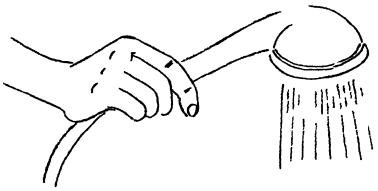
Кольцо, крючок или верёвочная петля на молнии помогают застёгиваться самому. Подобрать приспособления поможет специалист по эргореабилитации.

Мытьё и гигиена

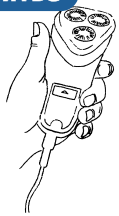
Вода — локтем



Ручной душ



Бритьё



Мытьё

- ванная тёплая, нескользящий коврик, поручни, всё нужное — под рукой;
- мыться **сидя** — на стуле для душа или сиденье для ванны;
- сначала холодная вода, потом горячая; проверять **локтем** или термометром (около 37 °C);
- сначала лицо и руки, интимную область — в последнюю очередь; кожу промокнуть, особенно складки;
- помощник рядом, дверь не запирать.

Рот и зубы

- чистить зубы и язык **утром, вечером и после еды**;
- пасты — совсем немного;
- протезы снимать и мыть.

Бритьё и ногти

- электробритва безопаснее обычной;
- ногти — раз в неделю, после мытья.

Если пациент лежит

Мыть по частям и сразу вытирать; пенки и лосьоны без смывания; после туалета — подмыть, вытереть, нанести защитный крем.

Средства ухода отметьте, что уже есть

Постель

- ☐ функциональная кровать с поручнями
- ☐ противопролежневый матрас
- ☐ подушки и валики для положения

Гигиена

- ☐ впитывающие пелёнки
- ☐ подгузники или впитывающие трусы
- ☐ пенка для мытья без воды
- ☐ защитный крем
- ☐ влажные салфетки
- ☐ одноразовые перчатки

Туалет и ванна

- ☐ кресло-туалет
- ☐ стул для душа или сиденье для ванны
- ☐ поручни
- ☐ нескользящий коврик

Еда и лекарства

- ☐ поильник, кружка с двумя ручками
- ☐ ложки с утолщёнными ручками
- ☐ тарелка с бортиком
- ☐ таблетница

Передвижение

- ☐ трость
- ☐ ходунки
- ☐ кресло-коляска

Высота трости и ходунков — до запястья опущенной руки.



Средства подбирает специалист — не покупайте наугад. При инвалидности их выдают по индивидуальной программе реабилитации (ИПРА).

Как избежать повторного инсульта

Двигайтесь

Быстрая ходьба, велотренажёр — не меньше **10 минут 4 раза в неделю**. Каждые 30 минут сидения вставайте на 3 минуты.

Питайтесь правильно

Овощи, фрукты, крупы, рыба 2 раза в неделю. **Соль — до 5 г в день.** Меньше колбас, выпечки, сладкого.

Без вредных привычек

Курение удваивает риск инсульта — бросайте полностью. Алкоголь — откажитесь или резко сократите.

Холестерин, вес, сахар

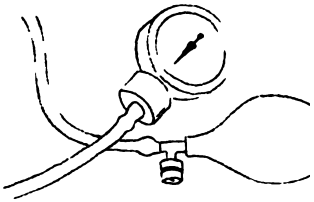
- «плохой» холестерин (ЛНП) — **ниже 1,4 ммоль/л**; статины — долго, не прерывая;
- индекс массы тела 18,5–24,9; талия меньше 102 см у мужчин и 88 см у женщин;
- при диабете — контроль сахара и лечение у эндокринолога.

Лекарства и школа

Лекарства — **каждый день, без перерывов**, не отменяйте сами. Врач и медсестра — главные источники совета; спросите, где проходит школа для родственников.

Давление показывайте дневник врачу

- измеряйте утром и вечером, сидя, после 5 минут отдыха, рука на столе;
- цель для большинства — **ниже 130/80 мм рт. ст.**, людям старше 80 лет цель назначает врач;
- таблетки — каждый день, даже если давление нормальное;
- выше 180/110, резко упало, сильно болит или кружится голова — вызывайте скорую.



Дата	Время	Давление	Пульс	Самочувствие	Лекарства

Когда звать врача

Сразу вызывайте скорую — 103 или 112

- внезапно ослабли рука или нога, перекосило лицо, нарушилась речь;
- резкая головная боль, рвота, судороги, потеря сознания;
- одышка, боль в груди;
- падение с сильной болью или ударом головы.

Скажите врачу или медсестре

- покраснение или пузырь на коже, которые не проходят, — начало пролежня;
- отёк, боль, покраснение ноги — возможен тромбоз;
- температура, кашель, поперхивание при еде и питье;
- боль в плече, рука или нога «тянет» (спастичность);
- запор больше 3 дней, задержка или недержание мочи;
- подавленность, плаксивость, отказ от еды и занятий.

Сайт «Реабилитация после инсульта»

реабилитацияпослеинсульта.рф

Материалы о восстановлении и профилактике, помощь в получении социальной поддержки. Наведите камеру телефона на QR-код.

Ваша реабилитационная команда

Лечащий врач _____

Заведующий отделением **Клепиков Евгений Юрьевич**

Врач физической и реабилитационной медицины **Давыдова Наталья Владимировна**

Рисунки положений и перемещений — из руководства С. Тайсон, Э. Эшбурн, Д. Джексон «Начните двигаться! Руководство по восстановлению двигательных функций после перенесённого инсульта» (СПб.: Политехника, 2001); рисунки одевания, мытья и гигиены — из «Справочника для тех, кто ухаживает за больными инсультом». Использованы материалы брошюры «Восстановление после инсульта: понятным языком — о самом главном» (социальный проект «Реабилитация после инсульта», реабилитацияпослеинсульта.рф, 2023).

Памятка составлена в соответствии с: приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых» (в ред. от 16.09.2025); приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»; клиническими рекомендациями «Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака» (Минздрав России, 2024) — позиционирование, ранняя мобилизация, профилактика пролежней, гигиена полости рта, вторичная профилактика, целевые уровни давления и холестерина; ГОСТ Р 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней»; материалами Общероссийской общественной организации «Союз реабилитологов России». Рекомендации подбираются индивидуально и не заменяют обучения специалистами отделения и назначений лечащего врача.

Данная памятка выдана в период госпитализации в неврологическом отделении для больных с ОНМК.

Терпение и правильные движения
делают уход легче, а восстановление — быстрее!

При признаках инсульта — сразу звоните **103** или **112**